جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مديحة عزقيال فهيم حبشى
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العمرانيه **العنوان :** +
رقم البطاقة : 27001012500406 **رقم التليفون :** 01221213694 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-01-1970 **المهنة :** صيدلي

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: مديحة عزقيال فهيم حبشى
National ID: 27001012500406

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مديحه
حزقيال فهيم حبشى
٧ ش شوقى حبيب من الثلاثينى
العمرانية - الجيزه

٢٧٠٠١٠١٢٥٠٠٤٠٦

JZ0858450



٢٧٠٠١٠١٢٥٠٠٤٠٦ ٢٠٢٣/٠٤
صيدلانية حره

انثى مسيحية متزوجة
جمال ابراهيم توفيلس
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٤/١٢

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :26-8-2024 جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) مديحه حزفيال فهيم بطاقة رقم 27001012500406

تليفون رقم: 01221213694

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنة مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :26-8-2024

الموظف المختص
مى ابو الخير

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1432795

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

Patient's Name:	Madiha Hazaqial Fahim Habashi
Date:	2026-06-14
Referred by:	Prof.Dr. no doctor
Hospital:	Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

(I) Chest:

- Still noted bilateral pulmonary nodules , one one right side , two on the left side , with the largest at right side still easuring 2 x 1.6 cm
- Still noted subcentemetric mediastinal lymph nodes .
- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.

CT Scan
[[BODY_PART_SCAN]]

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

أنت المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 22/10/2025 G

Name	[illegible]	MRN	٠٢٤١ ٢٨٧١
		ID	٢٧٠٠١٠١٢٥٠٠٤٦
Age	55	Phone	٠١٢٢١٢١٢٦٩٤
Menopausal status		Marital status	
NRS SCORE		Family history	
BMI		REASON OF MDT	Rec DT
CO morbidity			

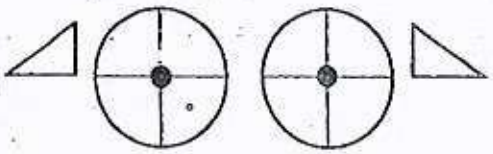
MDT

Clinical Data

BX:

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
3%	0%	0	

R L



TNM

Sonomammography:

Met lung Brst c

Mets Workup:

Recommendations:

Pt. is on DT
New PET-scan showed Metabolic progression of

MDT OUTCOME & PLAN Exhibit. type like pat. Node
SUV 5.3 (was SUV 3.3)
c Dec/16 + Zoledr

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / مديحه حزقيال فهيم حبشى	Request No.	: 13003601
Patient No.	: 27001012500406	Request Date	: 21/08/2024
Path No.	: SR-1208/24	Verification Date	: 05/09/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: breast cancer underwent lumpectomy & axillary clearance in 2013, presented with bilateral pulmonary nodules.
Nature of Specimen: Slide Revision.

Gross Examination:
- Four paraffin blocks labeled by (9095) and 15 slides were received.

Microscopic Examination:
1-Breast lumpectomy:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (2+2+2).
* DCIS: Focal.
* Angioinvasion: Not present.
* Perineural invasion: Not present.
* Lymph node involvement: Negative (0/15).
* IPT:
- ER: Intermediate nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 7/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane reaction of tumor cells (score 0).
- Ki67: 20% nuclear reaction of tumor cells.

2-Lung biopsy:
Sections examined revealed lung tissue infiltrated by irregular tubules & groups of malignant epithelial cells showing moderate atypia and occasional mitoses.
IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Weak incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+).
- CK: is positive.
- GATA3: is negative.

Verified by :
Dr.Rofayda Abdallah

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	:الأستاذه / مديحه حزقيال فهيم حبشى	Request No.	:13003601
Patient No.	:27001012500406	Request Date	:21/08/2024
Path No.	:SR-1208/24	Verification Date	:05/09/2024
Sex	:Female	Financial Category	: نفقة الدولة - أورام دار السلام
Age	:54 Y	Department	:Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	:Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- TTF1: is negative.

Diagnosis:
1-breast cancer, lumpectomy & axillary clearance, Slide revision:
Invasive duct carcinoma, grade II. Negative lymph nodes (0/15).
IPT:
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 20% of tumor cells
2-Bilateral pulmonary nodules, Slide revision:
Metastatic carcinoma of breast origin.

Signature
Prof. Dr. Amal Ahmed Hareedy.
Dr. Heba Hasan.
Dr. Rufaida Abdullah.

Verified by :
Dr.Rofayda Abdallah

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

Name : madiha hezekial habashi	**Date : 11-03-2026 10:37**
Branch : Portable	**Medical No. : GRI-78947**
Ref.Physician Prof : cap	**Ins.Company :**

MULTISCLICE NON CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Compared to the previous study dated 1/11/2025, the current study showed:

I- CHEST:

- No appreciable time interval changes regarding the size and number of the few previously seen bilateral upper lobe pulmonary nodules with spiculated margins largest still measuring 22 x 17 mm at the right upper lobe with adjacent consolidative patch.
- Rather stationary course regarding the size and number of the few subcentimetric previously seen mediastinal lymph nodes largest measuring 19 x 7 mm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness. No stones or back pressure changes.
- Normal plain C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name : madiha hezekial habashi	**Date : 11-03-2026 10:37**
Branch : Portable	**Medical No. : GRI-78947**
Ref.Physician Prof : cap	**Ins.Company :**

- Still noted L3 vertebral body lytic focus.

Opinion:

❖ **Stationary course since last study.**

Dr. Sherif Wagdy

Dr. Sherif Wagdy

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name: Madiha Ezekiel Fahim Date: 30-12-2025

MRN : 30183024 Referring Physician: Prof. Hanan Ezat

Follow up F18-FDG PET/CT STUDY

CLINICAL HISTORY:

- A 55-year-old female patient with history of left breast cancer.

REASON FOR PET/CT STUDY:

* Follow up.

TECHNIQUE:

- **Radiopharmaceutical:** 148 MBq of 18F FDG.
- **Time from 18F-FDG injection to scan:** 64 min
- **PET/CT images** were acquired from the skull base through the upper thighs & **CT images** were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- **Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.**

COMPARISON: to previous PET CT dated **12-6-2025.**

Reference hepatic activity is of SUVmax 3.1 (Was 2.9).

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

FINDINGS:

Head and Neck:

* No hypermetabolic cervical lymphadenopathy detected
* Regression of the previously noted FDG uptake of the thyroid gland with right lobe calcific nodule,US and Lab correlation.
* Dilatation of the left laryngeal ventricle with focal asymmetry of the left vocal cord and medialization still noted ?vocal cord paralysis .
* Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, and larynx.
* Normal diffuse brain activity with NO hypermetabolic brain lesions.

Chest:

* **Status post left CBS showing clear operative bed with no recurrent/residual lesions.**
* **There is no hypermetabolic mediastinal or axillary lymphadenopathy.**
* **Minimal metabolic regression with tationary morphological appearance of the previously seen bilateral upper lobes pulmonary nodules with speculated outline and related linear atelectasis, the largest at the right measures 2x1.5 cm with SUVmax 4.9 (was of SUVmax 5.9).**
* Faint subpleural reticulation seen at the left upper lung lobe, likely post therapeutic sequel.
* No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
* Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

* There is no hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
* The liver is average size and homogenous parenchymatous texture with NO FDG avid focal lesions detected.
* The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected.
* The pancreas shows normal FDG avidity.
* There are no active adrenal nodules.
* Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.

1 Seket Al-Emam st, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057
Fax: (202) 25 35 1745
E-mail: info@57357.org

ع سكة الإمام - السيدة زينب - القاهرة
ب: ١ الدواوين - مصر
ت: (202) 19057
ف: (202) 25 35 1745
57357
جمعية أصدقاء المرابطة للتوعية ضد السرطان
AFNCI
Egypt Cancer Network USA
Egypt Cancer Network Canada
Egypt Cancer Network
PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Musculoskeletal:

* Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.
* **ongoing healing fracture of right 7th, left 6th till 8th ribs for clinical correlation.**
* Mild spondylo-degenerative changes.

IMPRESSION:

- Still no evidence of hypermetabolic loco-regional tumor recurrence.
- Minimal metabolic regression with rather stationary morphologic course of the bilateral pulmonary nodules.
- No newly developed hypermetabolic metastatic sites.

Thanks for referral;

Dr Rehab Hussein, MD.
Consultant of Radio-diagnosis.

Dr. Rehab Maklad, MD
Consultant of Nuclear Medicine, CCHE

1 Seket Al-Emam st, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057
Fax: (202) 25 35 1745
E-mail: info@57357.org

ص.ب : ١ الدواوين - مصر
تليفون : (202) 19057
فاكس : (202) 25 35 1745
57357Eg

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]